

Nurse AI OS — الملف الإعلامي

nurse-ai-os.org · يوليو 2026 · للتواصل الإعلامي: great.ai.nurses@gmail.com

ملاحظة: الروابط في هذا الملف تؤدي إلى صفحات باللغة الإنجليزية. النسخة الأصلية بالإنجليزية: nurse-ai-os.org/assets/nurse-ai-os-media-packet.pdf

صياغات جاهزة للاستخدام موجهة إلى ثلاث فئات من الجمهور — عامة الناس، والمنظمات التمريضية، ومهندسي الذكاء الاصطناعي والصحافة التقنية — إضافة إلى حقائق سريعة، وسيرة المؤسس، وملاحظات الدقة، والمواد الإعلامية. كل ما يرد في هذا الملف قابل للاقتباس المباشر.

الملخص التنفيذي

Nurse AI OS هو نظام تشغيل مجاني ومحكوم للذكاء الاصطناعي الشخصي مخصص للممرضين والممرضات — بناء ممرض عمل 22 عامًا في العناية المركزة، انطلاقًا من قناعة بأن المهنة التي تحكم صرف الأدوية والتفويض ونطاق الممارسة قادرة على حوكمة الذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها. يمنح النظام طلاب التمريض، وممرضي الرعاية المباشرة، والمديرين، ورواد الأعمال من الممرضين نظام ذكاء اصطناعي عمليًا مدمجة فيه ثقافة السلامة التمريضية: تصنيفات مخاطر على كل مهمة، وبوابات موافقة بشرية، وحد صارم يمنع أي بيانات للمرضى على الإطلاق، وسلسلة توريد برمجية موقّعة وقابلة للتحقق. وهو عن قصد نظام مجاور للممارسة: يتولى الحياة المهنية المحيطة بالعمل — الدراسة، والشهادات المهنية، والملفات المهنية، وعمليات الوحدات، والمشاريع الجانبية — ويُبقي الجوهر السريري خارج النطاق بشكل دائم. وقد وصفت الإرشادات المهنية المستقلة الصادرة عن ANA (الرابطة الأمريكية للتمريض) وNCSBN (المجلس الوطني لمجالس التمريض الحكومية) وAAN (الأكاديمية الأمريكية للتمريض) ما يجب أن يكون عليه الذكاء الاصطناعي التمريضي الآمن؛ وNurse AI OS هو تلك الإرشادات وقد تحولت إلى نظام عملي — كما تخضع ادعاءاته البحثية لتحقيق خصامي، وتُنشر حالات الدحض بوصفها تصويبات علنية.

حقائق سريعة

- ما هو: طبقة تشغيل محكومة للذكاء الاصطناعي الشخصي، مصممة خصيصًا للممرضين، تعمل على بيئة التشغيل مفتوحة المصدر Hermes Agent (من Nous Research).
- لمن يقدّم: أربع وحدات جمهور على عمود حوكمة واحد — طلاب التمريض والمعلمون (Study OS)، وممرضو الرعاية المباشرة والممارسة المتقدمة (Bedside OS)، ومديرو التمريض والقادة (Leader OS)، ورواد الأعمال من الممرضين (Builder OS).
- التكلفة: مجاني للممرضين وطلاب التمريض خلال السنة التأسيسية.
- الحد الصارم: لا معلومات عن المرضى أبدًا — “إذا كان يمكن أن يحدد هوية مريض، فهو مشمول بالمنع”. تُرفض عند المدخل، لا تُخزّن ثم تُحذف. ولا قرارات سريرية في أي مستوى، بشكل دائم.

- نموذج السلامة: تصنيفات مخاطر EDENA (● المضي قدمًا / ● موافقة بشرية أولًا / ● مؤجل حتى مراجعة محكمة / ● توقف) — التصنيفات تقيس المخاطر لا الامتيازات. والمبدأ: الذكاء الاصطناعي يصوغ، والبشر يحكمون، والمرضون يرعون ("AI drafts, humans judge, nurses steward").
- الهندسة: إصدارات موقّعة (بصمة مفتاح مَثَبَتَة ← بيان موقّع ← مجاميع تحقق لكل ملف، مع الإغلاق عند الفشل)، وموافقة بشرية مرحلية على المهارات التي يكتبها الذكاء الاصطناعي، وقواعد ذاكرة تعتمد الرفض عند المدخل، ونمط "الحكم أولًا" المضاد للانحياز التشبثي.
- انضباط الأدلة: تحمل الادعاءات البحثية تصنيفات "متحقق منه / منقول عن المصدر / اجتهاد تصميمي"، وقد أكدت آخر جولة تحقق خصامي 24 ادعاءً من أصل 25، وضوّب الادعاء الوحيد المدحوض علنًا.
- المؤسس: Robert Domondon (روبرت دوموندون)، 22 — RN, CCRN, CSC, CMC — عامًا في العناية المركزة، و13 عامًا في الإدارة الصحية، وتدريب طبي (في الفلبين)، ومسؤول إداري سابق في مستشفى تابع للبحرية الأمريكية.

لعامة الجمهور

الوصف في 50 كلمة. Nurse AI OS هو نظام مساعد ذكاء اصطناعي مجاني للمرضى، مدمجة فيه قواعد السلامة التمريضية: لا يلمس معلومات المرضى أبدًا، ووافق إنسان على كل ما هو مهم، ويساعد في كل ما يحيط بالعمل — الدراسة، والشهادات المهنية، والجداول، والمسارات المهنية — ليصل المرضى إلى سرير المريض بحمل أخف.

الوصف في 150 كلمة. المرضى من أكثر المهنيين حظوة بالثقة في العالم — وهم، مثل غيرهم، يستخدمون بالفعل روبوتات الدردشة الذكية في شؤونهم اليومية. يمنحهم Nurse AI OS، الذي بناه ممرض عناية مركزة بخبرة 22 عامًا، خيارًا أكثر أمانًا من نافذة دردشة مفتوحة: نظام ذكاء اصطناعي شخصي يقوم على ثقافة السلامة التمريضية ذاتها. كل مهمة تحمل تصنيف مخاطر. وكل أمر مهم ينتظر موافقة الممرض. أما معلومات المرضى فترفض رفضًا قاطعًا — فالنظام مصمم بحيث لا يمكنه أن يصبح طريقًا مختصرًا حول الخصوصية. ما يفعله بدلًا من ذلك هو حمل عبء الحياة المحيطة بالعمل: التحضير لامتحانات للطلاب، ومواعيد الشهادات المهنية والتنظيف بعد المناوبات لمرضى الرعاية المباشرة، ومسودات الأوراق الإدارية للمديرين، وتسويق صادق للمرضى الذين يؤسسون مشاريع صغيرة. وهو مجاني للمرضى وطلاب التمريض خلال سنته التأسيسية. والشعار يروي القصة: الذكاء الاصطناعي يصوغ. والبشر يحكمون. والمرضون يرعون.

ثلاث رسائل رئيسية.

1. المرضى يستخدمون الذكاء الاصطناعي بالفعل — وهذا النظام يجعله آمنًا. الخيار ليس بين ذكاء اصطناعي أو لا ذكاء اصطناعي؛ بل بين محكوم وغير محكوم. وNurse AI OS هو الخيار المحكوم، من بناء ممرض.
2. خصوصية المرضى محمية بالتصميم لا بالوعود. يرفض النظام معلومات المرضى من الباب — فلا يخزنها أبدًا، ويصرّح بذلك بلغة واضحة.
3. الإنسان يبقى صاحب القرار. كل إجراء ذي عواقب ينتظر موافقة الممرض. الذكاء الاصطناعي يصوغ؛ والممرض يقرر.

زوايا مقترحة للتغطية. ممرض العناية المركزة الذي أمضى 22 عامًا إلى جانب سرير المريض وبنى نظام ذكاء اصطناعي على ثقافة قوائم التحقق التمريضية • ما الذي يمكن لكل مهنة أن تتعلمه من طريقة الممرضين في حوكمة الذكاء الاصطناعي • "لا بيانات مرضى، أبدًا": أداة الذكاء الاصطناعي التي تنصدر بما ترفض فعله.

اقتباس بارز. “لا ينبغي للممرضين أن يستخدموا الذكاء الاصطناعي فحسب — بل ينبغي أن يحكموه.” (Nurses “) — Robert Domondon, “they shouldn’t just use AI — they should govern it”

للمنظمات التمريضية

فقرة تعريفية جاهزة (اقتبسوا منها بحرية). Nurse AI OS هو طبقة تشغيل محكومة للذكاء الاصطناعي الشخصي بقيادة تمريضية، تحوّل الإرشادات المهنية المنشورة بشأن الذكاء الاصطناعي إلى نظام عملي. يتطابق تصميمه مباشرة مع المواقف التي سبق أن تبنتها ANA وNCSBN وAAN: الذكاء الاصطناعي رافد للحكم التمريضي لا بديل عنه أبدًا؛ والممرضون مسؤولون وحاضرون في حلقة القرار؛ والقدرات تُختبر قبل النشر ويُعاد التحقق منها باستمرار. تعمل كل مهمة تحت تصنيفات مخاطر EDENA مع بوابات موافقة بشرية؛ وتُرفض معلومات المرضى عند المدخل بموجب حد صارم يمنع أي معلومات صحية محمية (PHI)؛ وتُبنى مسارات النزاهة الأكاديمية على شفافية العملية بدلًا من درجات كشف غير موثوقة؛ ويحصل قادة التمريض على قوالب عملية جاهزة — سجلات مراجعة، وموائق سير عمل، وميثاق مساءلة للذكاء الاصطناعي على مستوى الوحدة — لأداء واجبات الإشراف التي تسند لها إلهم الإرشادات المهنية. وNurse AI OS مجاني للممرضين وطلاب التمريض خلال سنته التأسيسية.

نقاط للنقاش.

- إنه يحوّل الإرشادات القائمة إلى نظام عملي بدلًا من ابتكار إرشادات خاصة به. خريطة الربط بين مواقف ANA/NCSBN/AAN ومكونات النظام منشورة، استشهادًا استشهادًا، في تقرير العمارة الخاص بالمشروع — وقد صمدت تلك الاستشهادات أمام تحقق خصامي بثلاثة أصوات مقابل المصادر الأولية.
- إنه يبني القوى العاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي التي تفترضها الإرشادات. يمارس كل مستخدم يوميًا داخل تصنيفات المخاطر، وبوابات المراجعة، وقواعد التصعيد، وسجلات القرارات — وهي الحدوس المؤسسية التي تحتاجها المنظمات مع قدوم الذكاء الاصطناعي السريري. وتفيد برامج التمريض المستطلعة بوجود فجوة كبيرة في الإلمام بالذكاء الاصطناعي؛ ووحدة الطلاب موجهة إليها مباشرة.
- النزاهة الأكاديمية تُعالج بالطريقة التي تقول بها الأدلة. أدوات الكشف تعاني من مشكلات موثقة في الإيجابيات الكاذبة؛ لذا يبني Study OS النزاهة على قوالب الإفصاح، وسجلات العملية، ومسارات المراجعة والمقابلة بإشراف المعلمين — لا على الاتهام الآلي أبدًا.
- مراجعة الممرضين عنصر بنيوي. يراجع مجلس رعاية مكوّن من ممرضين معروفين بالاسم المهارات المشتركة وفق قائمة تحقق منشورة، مع صلاحية الحجر الصحي ودورة إعادة مراجعة كل 90 يومًا. والنشر لا يُقدّم أبدًا على أنه تزكية أو اعتماد.
- ما ليس هو (قولوه بوضوح): ليس برمجية سريرية، وليس نظام دعم قرار، وغير متصل بالسجل الصحي الإلكتروني، وغير مشمول بقانون HIPAA (ولا يدّعي ذلك أبدًا)، وليس برنامج اعتماد مهني، ولا يقدم أي ادعاءات بشأن نتائج المرضى.

دعوة التعاون. يمكن للمنظمات التمريضية والكليات والنقابات المهتمة بالبرامج التجريبية، أو ورش العمل (يتضمن الملف جلسة جاهزة للوحدات مدتها 90 دقيقة)، أو التعاون في الحوكمة، التواصل مع المشروع عبر great.ai.nurses@gmail.com.

لمهندسي الذكاء الاصطناعي والصحافة التقنية

فقرة تعريفية جاهزة (اقتبسوا منها بحرية). Nurse AI OS دراسة حالة في الذكاء الاصطناعي الشخصي المحكوم بمنطق المجال المهني: طبقة حوكمة فوق بيئة التشغيل مفتوحة المصدر Hermes Agent، تُفرض فيها خصائص السلامة بنيويًا حيثما سمحت بيئة التشغيل بذلك، وتوسم بصدق حينما لم تسمح. التوزيع سلسلة توريد موقّعة تُغلق عند الفشل (بصمة مفتاح مثبتة، وبيان موقّع بخوارزمية RSA، ومجاميع تحقق لكل ملف تُفحص قبل التنفيذ). أما المهارات التي يؤلفها الوكيل — إذ يكتب Hermes أدواته ويحسنها ذاتيًا — فتُعامل بوصفها سطح سلسلة توريد من الدرجة الأولى وتُوضع في قائمة انتظار مرحلية للموافقة البشرية. وتعمل الذاكرة على قوائم منع بالرفض عند المدخل بدلًا من سياسات الحذف اللاحق. وتُلاحق تصنيفات المخاطر بالمهام لا بالأدوات؛ وتُخصص أربع وحدات جمهور المهارات والإعدادات الافتراضية للتصنيفات من دون تفريع عمود الحوكمة. ويطبّق البرنامج البحثي للمشروع تحقيقًا خصاميًا بثلاثة أصوات على ادعاءاته هو، ناشرًا حالات الدحض بوصفها تصويبات — بما في ذلك ما يخص تسويقه هو نفسه.

نقاط للنقاش.

- **بوابات، لا انطباعات.** يعتبر التصميم التعليمات الدائمة ضرورية لكنها غير كافية لفرض الخطوط الحمراء. فالنقاط المفروضة آليًا (الكتابة المرحلية للمهارات، والموافقة على الأوامر، وفحوص رفض الإصدارات غير الموقّعة) تُميّز — صراحة وفي الوثائق العلنية — عن الأنماط التي يتبعها النموذج مثل تذييل التدقيق الذاتي في المستوى الأصفر، الذي يُراجع عند البوابة البشرية؛ ومدقق مخرجات يحجب التسليم هو خطوة التحسين التالية المعلنة. وقد صوّب المشروع وثائقه حين نُبّه مراجع إلى هذا التمييز. وعادة التصويب تلك هي القصة.
- **الوكيل جزء من سلسلة توريده هو نفسه.** في بيئة تشغيل تكتب أدواتها وتنسّق ذاكرتها بنفسها، لا يمكن للفحص أن يتوقف عند لحظة التثبيت: فالإيداع المرحلي `write_approval` مفعّل افتراضيًا، والفحص الأمني يُطبّق بصرف النظر عن المصدر، وقواعد “لا تتذكر” تُفرض في مواجهة سلوك بيئة التشغيل ذاته في تثبيت الذاكرة.
- **مقاومة الانحياز التثبتي كبنية للمهارات.** في كل ما يقارب القرار، يُستخلص تقييم الإنسان قبل عرض مادة الذكاء الاصطناعي — أي أن التخفيف من انحياز الأئمة مشقّر في ترتيب التفاعل، لا في النصائح.
- **مثال عملي على “تحويل حوكمة المجال القائمة إلى نظام تشغيلي”.** كانت المهنة قد نشرت متطلباتها (ANA وNCSBN وAAN)؛ والإسهام هنا هو الطبقة الآلية التي تحوّلها إلى نظام للاستخدام اليومي — وهو نمط قابل للنقل إلى أي مهنة منظمة.
- **اطلعوا على الإثباتات:** يحمل تقرير العمارة (بصيغتي HTML وPDF على nurse-ai-os.org/architecture-report.html) خريطة الربط من الإرشادات إلى البنية مع الاستشهادات الملخصة؛ ويخدم جدول مطابقة المعايير الخاص ب-naio-os المراجعين التقنيين.

المؤسس

السيرة القصيرة (50 كلمة). Robert Domondon (روبرت دوموندون)، RN, CCRN, CSC, CMC، ممرض رعاية حرجية أمضى 22 عامًا إلى جانب أسرة العناية المركزة، و13 عامًا في الإدارة الصحية، وتلقى تدريبًا طبيًا في الفلين، وتولى سابقًا إدارة مستشفى في قاعدة بحرية أمريكية. وهو مؤسس Nurse AI OS وNAIO Institute وNurse Intelligence Network.

السيرة المطولة (120 كلمة). تمتد مسيرة Robert Domondon عبر الطيف الكامل للرعاية الصحية: تدريب طبي وممارسة في الفلبين، وإدارة مستشفى في قاعدة بحرية أمريكية سابقة، وثلاثة عشر عامًا في الإدارة الصحية، واستشارات في تبيّي الذكاء الاصطناعي — وباختيار متعمد، أكثر من عقدين ممرضَ رعاية حرجة في الولايات المتحدة. هذا المزيج هو موجز التصميم لـ Nurse AI OS: نظام بناه شخص وقّع الميزانية، وكتب السياسة، وأمسك بيد المريض الذي كُتبت السياسة من أجله. ومبدؤه الحاكم — “الحوكمة بالتصميم؛ والوضوح والقيم قبل السرعة” — يسري في المنظومة التي أسسها: NAIOS Institute (المعايير والاعتماد)، و Nurse Intelligence Network (المجتمع المهني)، و EDENA (طبقة الأخلاقيات والمخاطر)، و Nurse AI OS نفسه.

المنظومة في لمحة

- Nurse AI OS — طبقة التشغيل المحكومة للذكاء الاصطناعي الشخصي (هذا المشروع؛ الباب الأمامي).
- EDENA — التصميم الأخلاقي والتمكين لتعزيز التمريض: طبقة تصنيف المخاطر والبوابات التي تعمل تحتها كل مهمة.
- NAIOS Institute — المعايير والاعتماد وأطر الامتثال لأنظمة القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
- Florence-X — مستوى التحكم التنسيقي للقوى العاملة المحكومة من وكلاء الذكاء الاصطناعي؛ يحتفظ البشر بسلطة القرار النهائي في كل طبقة.
- Nurse Intelligence Network (NIN) — المجتمع المهني العالمي والقيمة والبودكاست (nurseintelligence.com).
- Florence Media Network — محرك المحتوى؛ كل مادة تُصنّف وفق EDENA وتُراجع بشريًا قبل النشر.

ملاحظات الدقة — نرجو وصفنا على هذا النحو

الدقة في هذه النقاط أهم عند هذا المشروع من التغطية نفسها.

- **قولوا:** “نظام ذكاء اصطناعي شخصي محكوم للممرضين” (“a governed personal-AI system for nurses”) • “يرفض معلومات المرضى بالتصميم” (“refuses patient information by design”) • “مجاني للممرضين وطلاب التمريض خلال السنة التأسيسية” (“free for nurses and nursing students during the founding year”) • “يحوّل إرشادات ANA/NCSBN/AAN إلى نظام عملي” (“operationalizes ANA/NCSBN/AAN guidance”) • “مبني على بيئة التشغيل مفتوحة المصدر” (“built on the open-source Hermes Agent runtime”) “Hermes Agent”.
- **نرجو ألا تقولوا:** “متوافق مع” (“HIPAA-compliant”) “HIPAA” (فهو أداة شخصية غير مشمولة بالقانون ويصرّح بذلك) • “ذكاء اصطناعي سريري” أو “يشخص” أو “دعم القرار” (“clinical AI,” “diagnoses,” “decision support”) (فلاستخدام السريري خارج النطاق بشكل دائم) • “يعتمد الممرضين مهنيًا” (“certifies nurses”) (فإنتمام الدورات ليس أبدًا اعتمادًا للكفاءة) • “يحسّن نتائج المرضى” (“improves patient outcomes”) (فالمشروع لا يقدم أي ادعاءات بشأن نتائج المرضى أو نتائج السلامة أو الامتثال — بموجب سياسته).
- **الحد الفاصل في سطر واحد، قابل للاقتباس:** “لا معلومات صحية محمية، أبدًا — إذا كان يمكن أن يحدد هوية مريض، فهو مشمول بالمنع.” (“No PHI, ever — if it could identify a patient, it counts.”)

المواد والروابط

- الموقع: nurse-ai-os.org · ابدأ من هنا: nurse-ai-os.org/start-here.html · المسارات: nurse-ai-os.org/pathways.html
- تقرير العمارة (للقراء التقنيين والتنفيذيين): nurse-ai-os.org/architecture-report.html (مع نسخة PDF)
- الورقة البيضاء لذكاء الرعاية (يونيو 2026): nurse-ai-os.org/assets/care-intelligence-white-paper.pdf
- مقالات: “لماذا يحتاج الممرضون إلى نظام تشغيل للذكاء الاصطناعي، لا مجرد ذكاء اصطناعي” · “حوكمة قابلة للدحض: الأدلة وراء Nurse AI OS” — كلاهما على nurse-ai-os.org/nurse-station.html
- المجتمع: @NurseIntelligence · YouTube · nurseintelligence.com · البودكاست: The Nurse Intelligence Podcast (على Spotify)
- صورة المؤسس: متاحة عند الطلب (على nurse-ai-os.org/about.html)
- المقابلات والمحاضرات والبرامج التجريبية واستفسارات الحوكمة: great.ai.nurses@gmail.com

احملوا المصباح. واحفظوا السجل. الوكلاء يقترحون. والبشر يحكمون. والممرضون يرعون. (“Carry the lamp. Keep the ledger. Agents propose. Humans judge. Nurses steward”)